慢性胃炎、消化性溃疡、阑尾炎、胰腺疾病 ★☆☆（0~1题）

慢性萎缩性胃炎（2015）

特征：黏膜变薄、皱襞变浅、黏膜下血管清晰可见、腺体变小和减少、胃小凹变浅及囊性扩张、淋巴细胞和浆细胞浸润（病程长者可形成淋巴滤泡）、纤维化（1996、2008、2014）

腺上皮化生（2008）
- 假幽门腺化生（2023）
- 肠上皮化生（常见）（可有不典型/异型增生→可能癌变）
  - 完全型/小肠型/Ⅰ型：含有杯状、吸收、潘氏细胞
  - 不完全型/Ⅱ型：含有杯状细胞 —— 胃型/Ⅱa型；结肠型/Ⅱb型→可能导致肠型胃癌

（2007、2026）

	A型胃炎	B型胃炎（常见）
病因	自身免疫	Hp（常伴消化性溃疡）
抗壁细胞和内因子抗体	+	-
好发部位	胃体、胃底	胃窦
胃酸分泌	明显↓（缺乏）	正常或↓
血胃泌素	↑	↓
血 $VitB_{12}$	↓（常伴恶性贫血）	正常

消化性溃疡

病因：Hp、防御屏障↓和侵袭因素↑等（2019）

	胃溃疡	十二指肠溃疡（常见）
好发年龄	中老年	青壮年
好发部位	胃窦小弯侧	球部前壁

胃溃疡
- 圆形或椭圆形、多＜2cm、边缘整齐如刀切、底部平坦、深达肌层、阶梯状（贲门侧深+幽门侧浅）
- 周围黏膜皱襞呈放射状向溃疡集中（溃疡底部瘢痕牵拉）
- 溃疡底部由内向外（2007、2013）
  - ①炎性渗出层：中性粒细胞等白细胞、纤维素
  - ②坏死组织层：伊红色坏死组织（纤维素样坏死）
  - ③肉芽组织层：大量新生毛细血管和成纤维细胞
  - ④瘢痕组织层：增殖性动脉内膜炎（管腔狭窄闭塞、血栓）→影响再生使溃疡不易愈合、但防止破裂出血

并发症
- ①出血：最常见
- ②穿孔（2022）：胃溃疡好发于胃小弯、十二指肠溃疡好发于球部前壁
- ③幽门狭窄
- ④癌变：胃溃疡癌变率多＜1%（来自溃疡边缘）、十二指肠溃疡几乎不癌变

急性阑尾炎

- ①单纯性
- ②化脓性（蜂窝织炎）
- ③坏疽穿孔性→急性弥漫性腹膜炎、阑尾周围脓肿

中性粒细胞等浸润

急性胰腺炎

- 水肿性/轻型（常见）
- 出血坏死性/重型 —— 胰腺大片凝固性坏死、胰腺周围脂肪坏死（特殊液化性坏死）、黄白色斑点（钙皂）

胰腺癌

- 好发部位：胰头
- 最常见组织学类型：导管腺癌